Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ»

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ»

ТАШКЕНТ – 2025

"СОГЛАСОВАНО"
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Х.Г. Фозилов

_____

_____ _____ 2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ»

ТАШКЕНТ – 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИЯМ

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ

Кодирование по МКБ-10:	**Нозологическое название:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения**	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
I47.1	Наджелудочковая тахикардия	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог
I47.9	Пароксизмальная тахикардия неуточненная	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

Кодирование по МКБ-11:	**Нозологическое название:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения**	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
BC81.Y	Другая уточненная наджелудочковая тахиаритмия	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

BC81.Z	Наджелудочковая тахиаритмия, неуточненная	ВОП/ Кардиолог/ Терапевт	Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Кардиолог / Терапевт / Интервенционный кардиолог (аритмолог)	Реаниматолог / Кардиохирург / Интервенционный кардиолог / Эндокринолог / Невропатолог / Нефролог

***при заполнении стандарта необходимо указать нозологию, ее течение у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также характер периода заболевания по нозологии.**

Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, если по нозологии не ведется хирургическая практика, таблица (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ) не заполняется, или если нозология не включает паллиативное лечение - не заполняется таблица (ПАЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ).

ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПЕНСАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТДЕЛЕННОЙ НОЗОЛОГИИ
НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Консультация основного специалиста (врача)	1. Семейный врач	+	+				По крайней мере, в период медицинского осмотра 2 раза; 1 раз при наличии заявления по болезни и при наличии указания	Амбулаторное наблюдение продолжается на протяжении всей жизни; Стационарное лечение: 5-10 дней*
	2. Кардиолог		+	+	+	+		
	3. Интервенционный кардиолог (аритмолог)				+	+		
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительно)	1. Реаниматолог			+	+	+	- Проводит 1 обследование в случае заявления по заболеванию и полное обследование в случае показания.	
	2. Интервенционный кардиолог				+	+		
	3. Кардиохирург					+		
	4. Эндокринолог		+	+	+	+		
	5. Невропатолог	+	+	+	+	+		
	6. Нефролог	+	+	+	+	+		
Примечание: (согласно инструкции)								
Основные лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ крови	+	+	+	+	+	– 1 раз в случае заболевания и/или по инструкции. – Назначается 2 раза в 1 год (ОАК, Биохимия,	
	2. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+		
	3. АЛТ, АСТ, билирубин		+	+	+	+		
	4. Креатинин			+	+	+		
	5. Мочевина			+	+	+		
	6. СРБ			+	+	+		
	7. АСЛО			+	+	+		

	8. РФ			**+**	**+**	**+**	липидный спектр, ОАМ)	
	9. Коагулограмма			**+**	**+**	**+**		
	10. ТТГ			**+**	**+**	**+**		
	11. Электролиты			**+**	**+**	**+**	Не менее 1 раза в период стационарного лечения заболевания и/или по инструкции.	
Примечание: если на материально-технической базе СВП/СП имеется возможность обследования острофазных проб (СРБ, АСЛО, РФ) и ТТГ, данные обследования должен проводить семейный врач. Количество лабораторных исследований в стационарных условиях определяется исходя из клинического состояния.								
Дополнительные лабораторные исследования	**1. Уровень сахара в крови**	+	+	+	+	+	– 1 раз в случае заболевания и/или по инструкции.	
	2. Высокочувствительные тропонины.		+	+	+	+		
	3. МВ-КФК			+	+	+		
	4. Мозговой натрийуретический пептид.			+	+	+		
	5. Липидный спектр		+	+	+	+		
	6. Оценка кислотно-щелочного баланса.			+	+	+		
	7. Д-димер			+	+	+		
	8. Общий белок		+	+	+	+		
	9. Концентрация анти Ха фактора в крови.					+		
	10. Гепатит В,С			**+**	**+**	**+**		
	11. ВИЧ			**+**	**+**	**+**		
	12. Группа крови							
	13. RW			**+**	**+**	**+**		
Примечание: лабораторные исследования обязательно проводит лечащий врач, результаты этих анализов направляются узким специалистам следующего уровня. Повторное лабораторное обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения. При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинских учреждений. Гепатит В,С, ВИЧ, RW и группа крови должны проверяться у пациентов, у которых планируется хуриргическое вмешательство.								

Основные инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	+	+	+	- 1 раз при обращении по болезни и/или по инструкции - Планово 2 раза в 1 год (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ) **- не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или согласно инструкции.**	
	2. Холтеровское мониторирование ЭКГ (24-72 часа)		+	+	+	+		
	3. Трансторакальная ЭхоКГ		+	+	+	+		
	3. Электрофизиологическое исследование (инвазивное, неинвазивное)				+	+		
Примечание: В стационарных условиях количество исследований определяют исходя из клинического состояния.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. Трансэзофагеальная ЭхоКГ				+	+	При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.	
	2. Рентгенография грудной клетки		+	+	+	+		
	4. Стресс ЭКГ (ВЭМ, Тредмил)		+	+	+	+		
	5. Стресс-ЭхоКГ				+	+		
	6. Коронарография				+	+		
	7. МРТ сердца				+	+		
	8. МСКТ-обследование сердца				+	+		
Примечание: инструментальные диагностические исследования проводит лечащий врач. При наличии показаний к лечению в медицинском учреждении другого уровня оно будет направлено вместе с копиями обследования. Повторное инструментальное диагностическое обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.								

Показания к плановому стационарному лечению (без операции):

1. Дневной стационар не распространяется на кардиологических пациентов. Если у пациентов подтверждена наджелудочковая тахикардия, их следует госпитализировать.
2. Показания для госпитализации в кардиологическое или терапевтическое отделение клинической больницы и/или районного медицинского объединения и/или частной клиники: - пароксизм наджелудочковой тахикардии;
3. Показания для направления в клиники областных филиалов Республиканского специализированного научной -практического медицинского центра кардиологии: - частые пароксизмы наджелудочковой тахикардии; - наджелудочковые тахикардии неясного генеза;
4. Показания для направления в клиники Республиканского специализированного научной -практического медицинского центра кардиологии или кардиологическое отделение клиник вузов: Частые пароксизмы наджелудочковой тахикардии устойчивых к ОМТ; - наджелудочковые тахикардии неясного генеза, гемодинамически нестабильные наджелудочковые тахикардии;

Инструкция по неотложному стационарному лечению (хирургической практике):

1. Хирургические вмешательства в условиях районных медицинских объединений не проводятся.
2. Показания к обращению в региональное отделение скорой медицинской помощи и/или реанимации областного многопрофильного центра и/или областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии: - гемодинамически нестабильные наджелудочковые тахикардии, острая сердечная недостаточность, стенокардия, нарушения мозгового кровообращения, брадикардия, тахикардия, осложненные эпизоды наджелудочковой тахикардии, при фибрилляции предсердий;
3. Направление в Республиканский специализированный научно -практический медицинский центр кардиологии или отделение кардиохирургии или хирургической аритмологии клиник высших учебных заведений: - пациенты с наджелудочковыми тахикардиями; - для радиочастотной аблации; - для реваскуляризации миокарда;
4. Осложнения заболевания: - острая/хроническая сердечная недостаточность; - внезапная сердечная смерть; - тромбоэмболические осложнения

	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Диагностические мероприятия	1. Определение локализации дополнительного пучка проведения на ЭКГ по алгоритму Арруды				+	+	При планировании на РЧА	
	2. Почечный клиренс по Кокрофту		+	+	+	+	Перед проведением РЧА.	

Примечание: Наджелудочковая тахикардия возникающая вследствие дополнительного пучка проведения (WPW синдром) необходимо оценить ЭКГ и

определить вероятную локализацию дополнительного пучка проведения для планирования доступа (левосторонний или правосторонний), при левосторонней локализации необходимо антикоагулянтная терапия (гепарин в/в) .

(МЕДИКАМЕНТОЗОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное лечение)		По уровню и виду ПЛАНОВОЙ медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка				
Название препарата (не патентовано международное).	Дозировка и способ применения препарата	ОШП/ОП	КТМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Амиодарон* (Не применять одновременно с ААП IC класса.) препарат выбора при наличии органических заболеваний сердца (Ширококомплексная регулярная тахикардия)	Гемодинамически стабильные пациенты - 5 мг/кг Кордарона разведенное в 20 мл 5% раствора глюкозы внутривенно		+	+	+	+	В зависимости от клинической ситуации инъекции, при гемодинамически нестабильных аритмиях, 150 мг в/в струй, стандартная 300 мг в/и капельно.	-
Верапамил** Не применять одновременно с ААП II класса. (Узкококомплексная регулярная тахикардия)	Гемодинамически стабильные пациенты 0,075-0,15 мг/кг. Верапамила в/в в течение 2 минут		+	+	+	+	В зависимости от клинической ситуации инъекции, при гемодинамически нестабильных аритмиях в среднем 5-10 мг	
II класс антиаритмические препараты, ААП (применять только один из ниже приведенных ААП II класса)	2,5-5 мг 1-2 раз / сутки	+	+	+	+	+	2,5-10 мг/день	длительно
Небивалол ** (не рекомедуется при WPW синдроме)	2,5-10 мг 1 раз / сутки.	+	+	+	+	+	2,5-10 мг/день	

Или Бисопролол ** (не рекомедуется при WPW синдроме)								
	3,125-25 мг 2 раза / сутки.	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**3125–25 мг/день**	
Или Карведилол **	**25-100 мг 1-2 раза / сутки**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**25-100 мг/день**	
Или Метопролола сукцинат **	**10-40 мг 4 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**120 мг/день**	
Или Пропанолол**								
Антиаритмические средства I С класса (Не применять одновременно с ААП III класса.)	**150-300 мг по 1 таблетке 3 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**450 мг/день**	**-**
Пропафенон * (не рекомендуется при наличии органических заболеваний сердца)								
или Аллапинин*/ Аксаритмин*	**25-50 мг 3 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**75 мг/день**	**-**
Препарат выборо если нет органического/структурного заболевания сердца, не рекомендуется во время беременности (не рекомендуется при наличии органических заболеваний сердца)								
или Этацизин*	**25-100 мг 1 таблетка 3 раза**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**150 мг/день**	**-**
Препарат выборо если нет органического/структурного заболевания сердца, не рекомендуется								

во время беременности (не рекомендуется при наличии органических заболеваний сердца)								
Узкокомплексная тахикардия IV группа антиаритмические средства (Не применять одновременно с ААП II класса.) Верапамил ** (не рекомедуется при WPW синдроме) или Дилтиазем ** или (не рекомедуется при WPW синдроме)	**240-480 мг/ сут .**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**360 мг/сут,**	**-**
	120-360 мг/день	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**180 мг/день**	**-**
Примечание. * Не рекомендуется применять эти препараты одновременно. ** - Эти препараты нельзя применять одновременно с бета-блокаторами. В зависимости от типа аритмии (узкокомплексная, ширококомплексная) применяют один из I класса ААП или один из III класса ААП, при неэффективности можно сочетать с одним из ААП II класса. Лечебные мероприятия (дополнительное лечение) при наличии основного заболевания (ИБС, АГ, СД, ХСН) необходимо применять лекарственные средства по стандартам основного заболевания.								

Лечебные мероприятия (основное лечение)		**По уровню и виду ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи**					**Средняя суточная дозировка**	**Дозировка на один курс**
		Амбулаторное лечение		**Стационарная поддержка**				
Название препарата (не патентовано международное).	**Дозировка и способ применения препарата**	**ОШП/ОП**	**КТМП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения республиканского уровня**		
Синхронизированная электрическая кардиоверсия (Гемодинамически нестабильные пациенты)	**1-3 раза (до купирования тахикардии)**		**+**	**+**	**+**	**+**	**1-3 раза (до купирования тахикардии)**	**-**

Вагусные пробы (Гемодинамически стабильные пациенты)	**1 раз, при неэффективности повторить пробу через 5-10 минут**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1 раз, при неэффективности повторить пробу через 5-10 минут**	**-**
Аденозинтрифосфат (АТФ)	**Начальная доза 3 мг в/в болюсно (в течение 2 секунд), если тахикардия не купировалась в течение 2 минут, необходимо повторить в/в введение болюсно в дозе 6 мг., если тахикардия не купировалась в течение 2 минут после второй дозы, необходимо повторить в/в введение болюсно в дозе 12 мг.**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1-3 раза (до купирования тахикардии). Если тахикардия не купировалась после третьей дозы, введение следующих доз не рекомендуется**	
Амиодарон* (препарат выбора при наличии органических заболеваний сердца) **(Ширококомплексная регулярная тахикардия)**	**Гемодинамически стабильные пациенты - 5 мг/кг Амиодарона разведенное в 20 мл 5% раствора глюкозы внутривенно**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**В зависимости от клинической ситуации инъекции, при гемодинамически нестабильных аритмиях, 150 мг в/в струй, стандартная 300 мг в/и капельно.**	**-**
Верапамил** **(Узкококомплексная регулярная тахикардия)**	**Гемодинамически стабильные пациенты 0,075-0,15 мг/кг. Верапамила**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**В зависимости от клинической ситуации инъекции, при гемодинамически**	

	в/в в течение 2 минут						**нестабильных аритмиях в среднем 5-10 мг**	

Примечание. * Не рекомендуется применять эти препараты одновременно с ААП IC класса. ** - Эти препараты нельзя применять одновременно с бета-блокаторами.
В зависимости от типа аритмии (узкокомплексная, ширококомплексная) применяют один из I класса ААП или один из III класса ААП, при неэффективности можно сочетать с одним из ААП II класса. АТФ необходимо применять с осторожностью под монитором и при наличии реанимационных оборудований.
Лечебные мероприятия (дополнительное лечение) при наличии основного заболевания (ИБС, АГ, СД, ХСН) необходимо применять лекарственные средства по стандартам основного заболевания.

(ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	**По уровню и виду плановой/экстренной медицинской помощи**				
	Амбулаторное лечение		**Стационарная поддержка**		
Название операции/вмешательства/лечения	**СВП/СП**	**МПЦП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения республиканского уровня**
1. Катетерная аблация (радиочастотная/криобаллонная)					**+**
2. Электрическая кардиоверсия		**+**	**+**	**+**	**+**
3. Хирургическая абляция					**+**
4. Установка кардиостимулятора (временный, постоянный)				**+**	**+**
5. Практика баллонной ангиопластики и стентирования коронарных артерий				**+**	**+**
6. Аорто-коронарное шунтирование				**+**	**+**

Комментарий: Катетерная аблация рекомендуется при симптомных и частых пароксизмах НЖТ [класс I, A]. Хирургическую аблацию проводят в случаях, когда нет других показаний к операции на открытом сердце, кроме 1 и более неудачных внутрисердечных катетерных аблациях. Аблация АВ-узла рекомендуется пациентам с частыми симптомными пароксизмами предсердной тахикардии, с дальней имплантацией стимулирующих устройств (ЭКС, СРТ, ИКД) к сердечной ресинхронизации (сердечная недостаточность III–IV функционального класса по NYHA, ФВЛЖ <35% и длительность QRS >130 мс, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию). Установка сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) - Абсолютное показание к установке ИКД выше + пучка Гис при блокаде левой ноги, ширине QRS более 130 мс и ФВЛЖ менее 35%, кроме вышеперечисленных показателей у больного стабильная ХСН и продолжительность жизни более 1 года
ЧКВ: если в коронарном бассейне имеется 1 или 2 поражения сосудов (оценка SYNTAX ниже 32 баллов) и оптимальная медикаментозная терапия

недостаточно эффективна.
АКШ: при 3-х и многососудистом поражении коронарного бассейна (балл SYNTAX выше 32 баллов), либо при поражении левой коронарной артерии, либо при наличии СД.

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка		
Диетическая таблица и ее продолжительность	СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Стол №10 – на всю жизнь Соответственно определяют этиологию предсердных тахиаритмий.	+	+	+	+	+

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансерная деятельность	Название медицинских услуг	СВП/СП	ЦМКП	Минимальное количество событий	Период диспансерного контроля
Консультация эксперта (врача)	1. Медсестра	+	+	1 раз в 6 месяцев	
	2. Семейный врач	+	+		
	3. Кардиолог		+		
	4. Невролог		+	По показаниям	
	5. Эндокринолог		+		
Лабораторные испытания	1. Общий анализ крови	+	+	По показаниям	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. Содержание сахара в крови	+	+		
	4. Креатинин в крови	+	+		
	5. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	6. Коагулограмма	+	+		
	7. ТТГ		+		
Примечание. При периодических обследованиях согласно инструкции рекомендуются дополнительные лабораторные исследования. * Эти специалисты будут осмотрены регионом/МИАТМ по рекомендации кардиолога. **Реализуется исходя из материально-технических возможностей учреждения.					
Инструментальные исследования	1. ЭКГ	+	+	1 раз в 6 месяцев	
	2. ЭХОКГ		+	По показаниям	

	3. ХМЭКГ		**+**		
	4. Рентген грудной клетки		**+**		
Примечание. Во время периодических осмотров рекомендуется проводить дополнительные инструментальные проверки. * для проведения данных исследований пациент регулярно направляется в региональные/НПМЦ/многопрофильные центры по рекомендации кардиолога.					